

39. DÉVELOPPEMENT DE L'ANSE INTESTINALE

DURÉE : 20:47

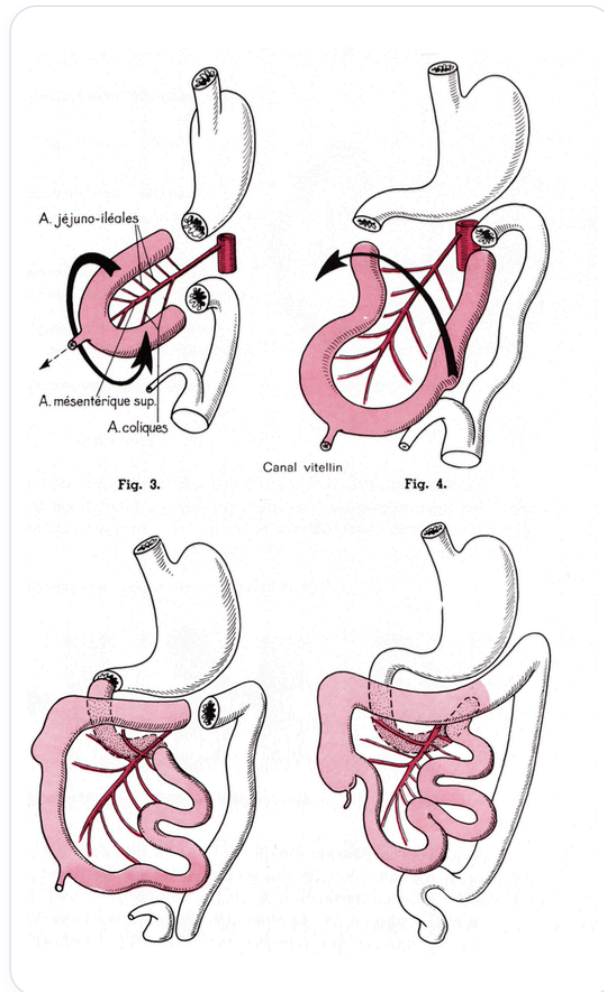
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit le développement embryologique de l'anse intestinale, en mettant l'accent sur la rotation antihoraire de l'intestin, l'importance de l'artère mésentérique supérieure et son influence sur la dynamique de croissance intestinale. Les concepts clés abordés incluent la relation entre l'estomac, le foie et le cœur, ainsi que les différents points d'appui essentiels pour le développement et le fonctionnement de l'intestin. De plus, la vidéo explore les liens entre les émotions et la santé intestinale, détaillant comment des sentiments comme la colère ou la peur peuvent affecter la digestion. Vous apprendrez également l'importance de considérer la dynamique péritonéale lors du traitement des troubles intestinaux, enrichissant ainsi votre approche thérapeutique en ostéopathie.

DÉVELOPPEMENT DE L'ANSE INTESTINALE

Le **cordon ombilical** est initialement volumineux, mais il va se réduire au fil du développement. Au départ, l'**intestin** se développe en dehors de la cavité péritonéale, en raison d'un **apport trophique** important, principalement fourni par l'**artère mésentérique supérieure**. Cette artère, qui se divise à partir de l'aorte, constitue l'axe de la rotation intestinale.

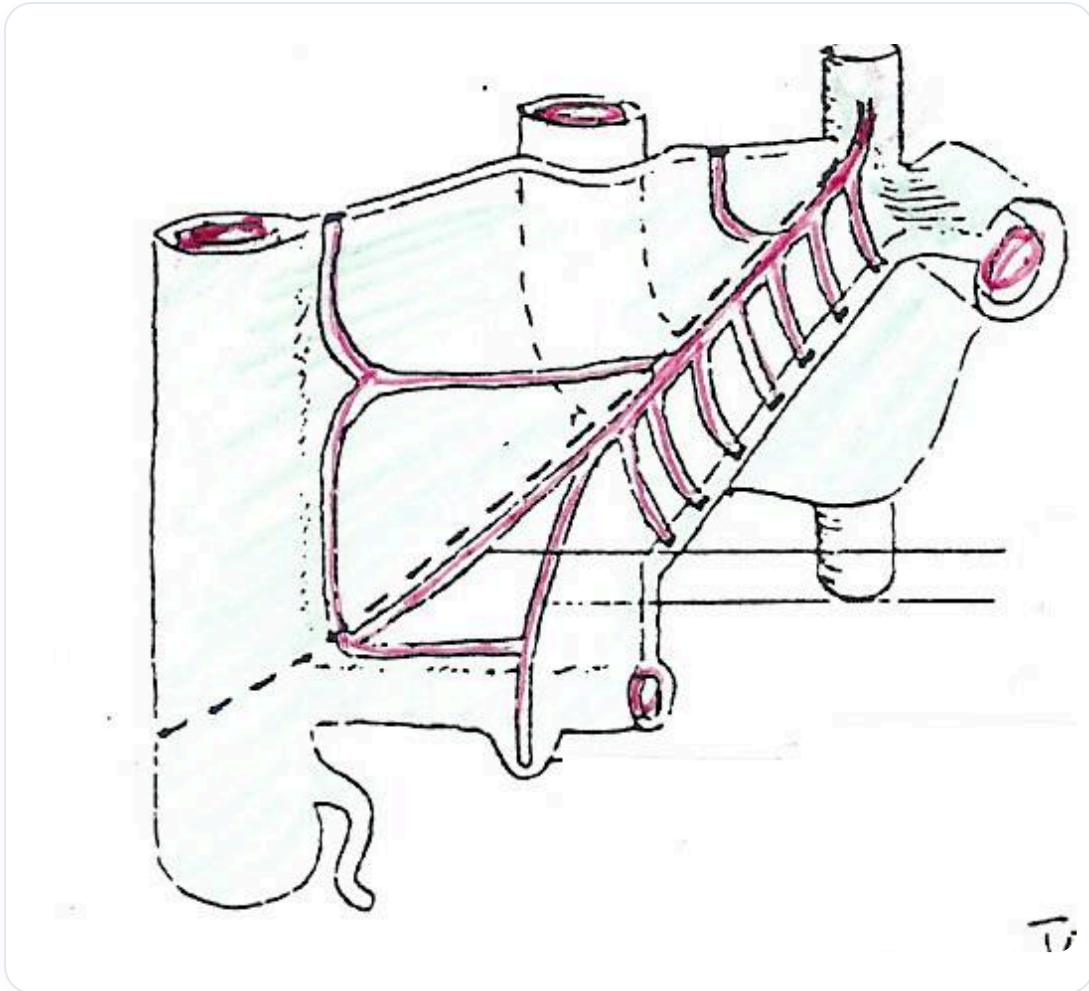


Rotation anse intestinale

La rotation de l'intestin se fait dans un sens **antihoraire**, de l'avant vers l'arrière. En parallèle, se met en place un **tube hépatogastrique** et un tube digestif. On observe également une structure mésodermique, qui est enveloppée dans un tissu, correspondant à la **tâche future** au niveau ombilical, le **canal ophalo-mésentérique**. Les vaisseaux sanguins se développent davantage dans cette région.

On constate une **synchronicité** entre l'estomac et la rotation de l'intestin. Lorsque l'estomac se positionne vers la gauche, le foie se déplace vers la droite. Ce mouvement entraîne également une mise en place du cœur à gauche, provoquant une congestion splénique. Le **colon** commence à se gonfler, et l'artère mésentérique supérieure devient le point d'appui fondamental pour le développement intestinal.

Sur le plan vertébral, l'artère mésentérique supérieure correspond à l'axe de **D12-L1**, qui est lié aux zones d'insertion des piliers diaphragmatiques. Ce point d'appui est essentiel pour le corps et influence la dynamique de croissance de l'intestin.

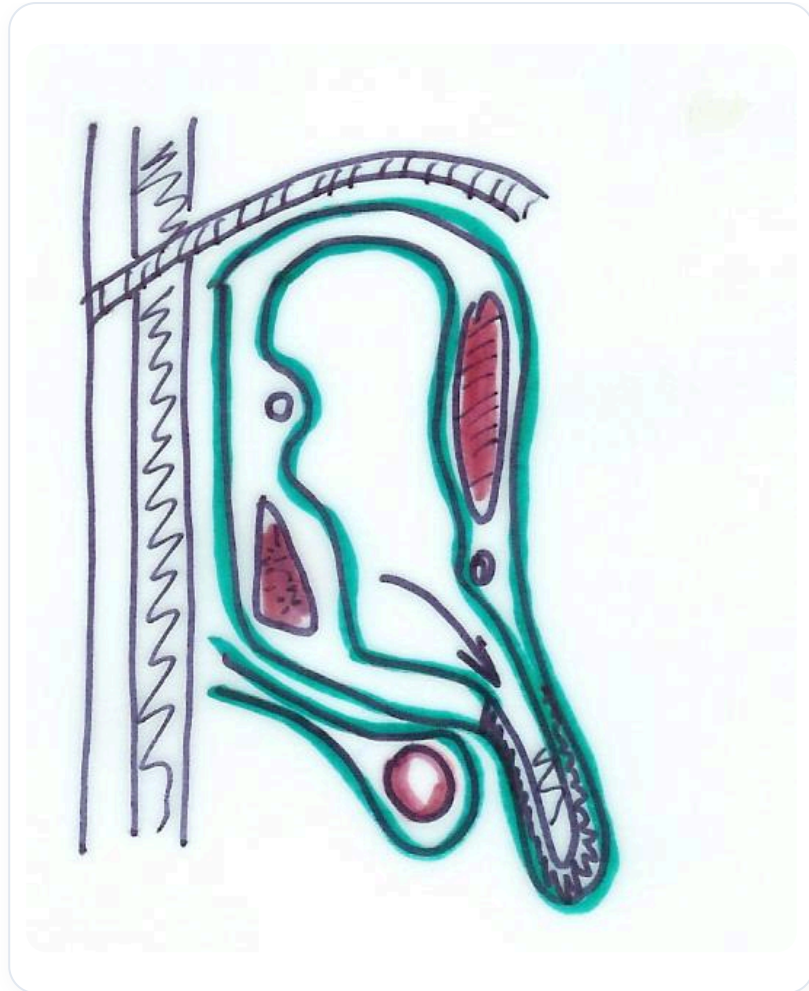


Troncs artériels embryonnaires

La croissance de l'intestin est caractérisée par des **vitesse différentielles** liées à des polarités. Une concentration métabolique plus importante se développe vers le haut, tandis que la partie inférieure croît moins rapidement, formant ainsi l'ébauche de l'**angle colique gauche**. Ce mouvement de croissance et de rotation est crucial pour la formation de l'intestin.

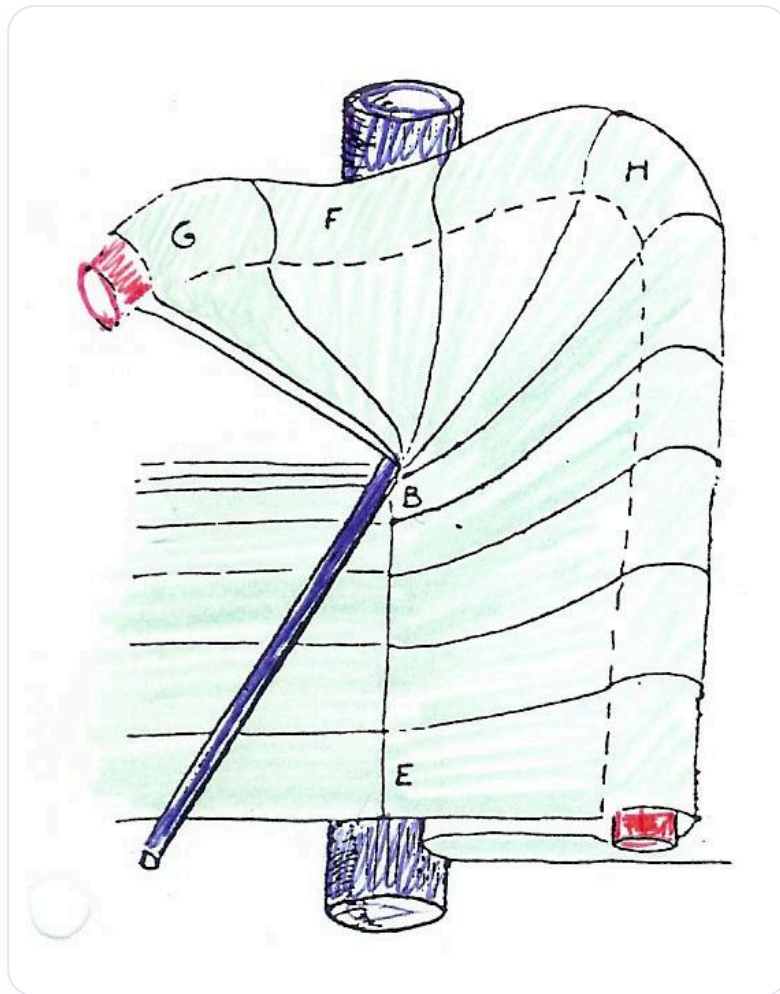
En observant la dynamique de l'intestin, on peut identifier plusieurs points d'appui importants : l'artère mésentérique, l'angle colique gauche, et le cadre duodénal. Ces points d'appui sont essentiels pour le développement et la fonction de l'intestin.

Le **canal ophalo-mésentérique**, qui est l'axe de rotation, se termine par un reliquat appelé le **diverticule de Meckel**, situé entre l'axe pubien et le cæcum. Le développement du cerveau est également dépendant du système vasculaire digestif. Si l'apport trophique est insuffisant, cela peut entraîner des complications.



Circulation villosités intestinales

La réintégration de l'intestin se produit au cours du développement, notamment autour du troisième mois de grossesse, lorsque le cordon ombilical commence à se former.



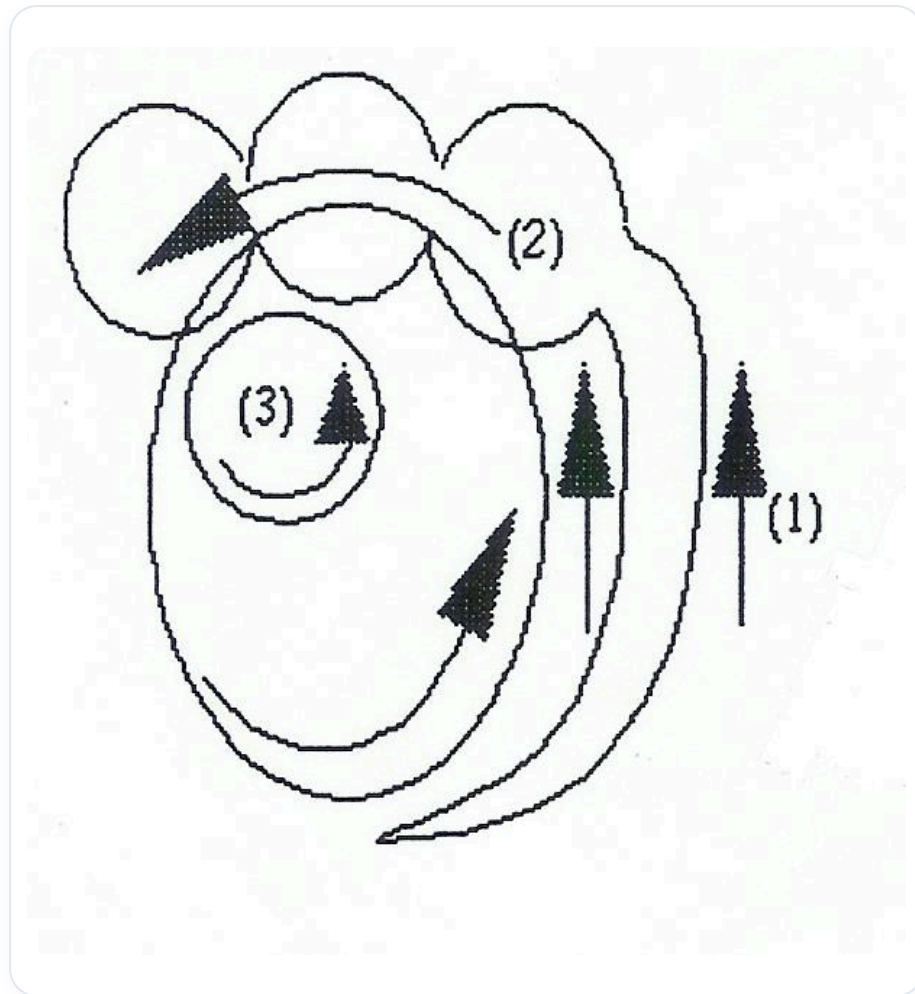
Pli ventral/latéral embryonnaire

Ce processus est crucial pour établir les connexions avec la mère, notamment à travers la **cavité amniotique**, qui permet des échanges électrolytiques et hormonaux.

Les émotions et les états d'âme sont également liés à la santé intestinale. Le **colon ascendant** est associé aux injustices alimentaires, tandis que le **colon transverse** représente les humeurs de l'âme. Les émotions telles que la colère et la peur peuvent influencer la santé digestive.

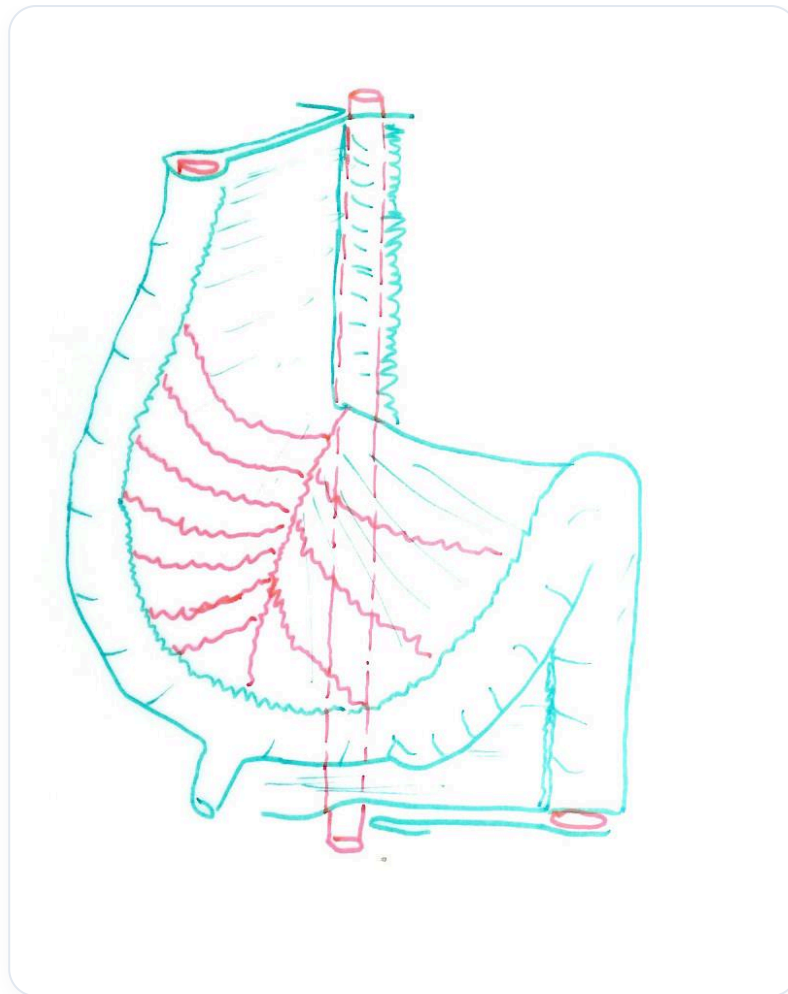
Le **colon descendant** est lié à des problématiques familiales et à la recherche d'indépendance. L'**appendice** et le **cæcum** jouent un rôle important dans la défense immunitaire. Les problèmes intestinaux chez les enfants, tels que les **appendicites**, peuvent être liés à des phases de développement embryonnaire.

Le traitement des troubles intestinaux doit prendre en compte la dynamique péritonéale et les relations entre les différents organes.

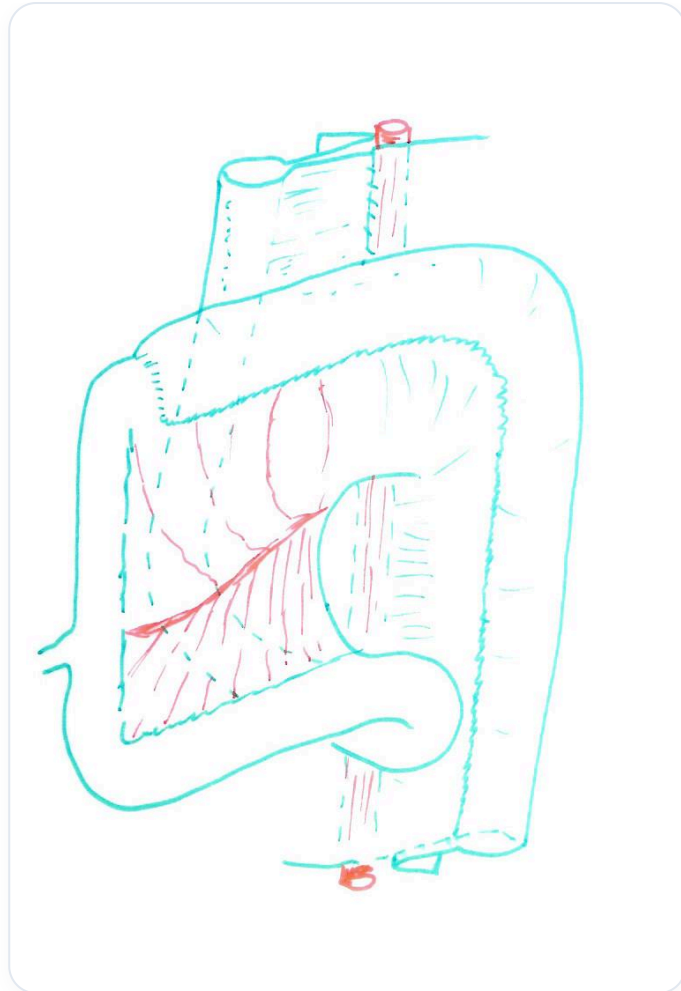


Tourbillon embryologique

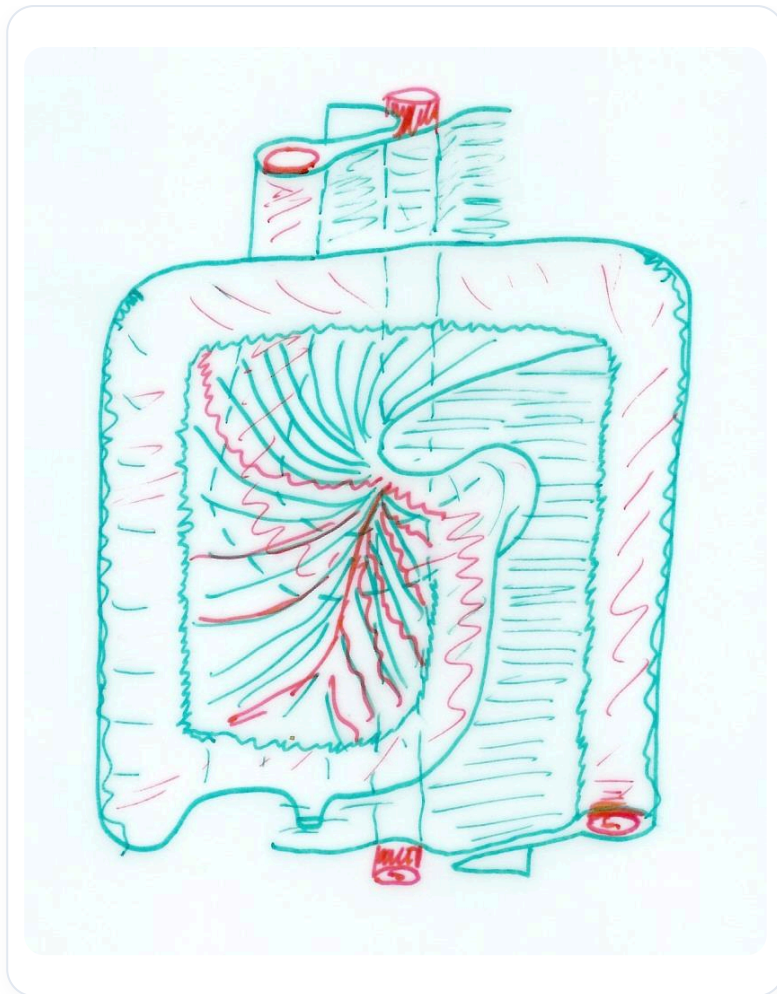
La stabilisation du cadre péritonéal peut aider à résoudre de nombreux problèmes de santé, notamment les infections et les inflammations.



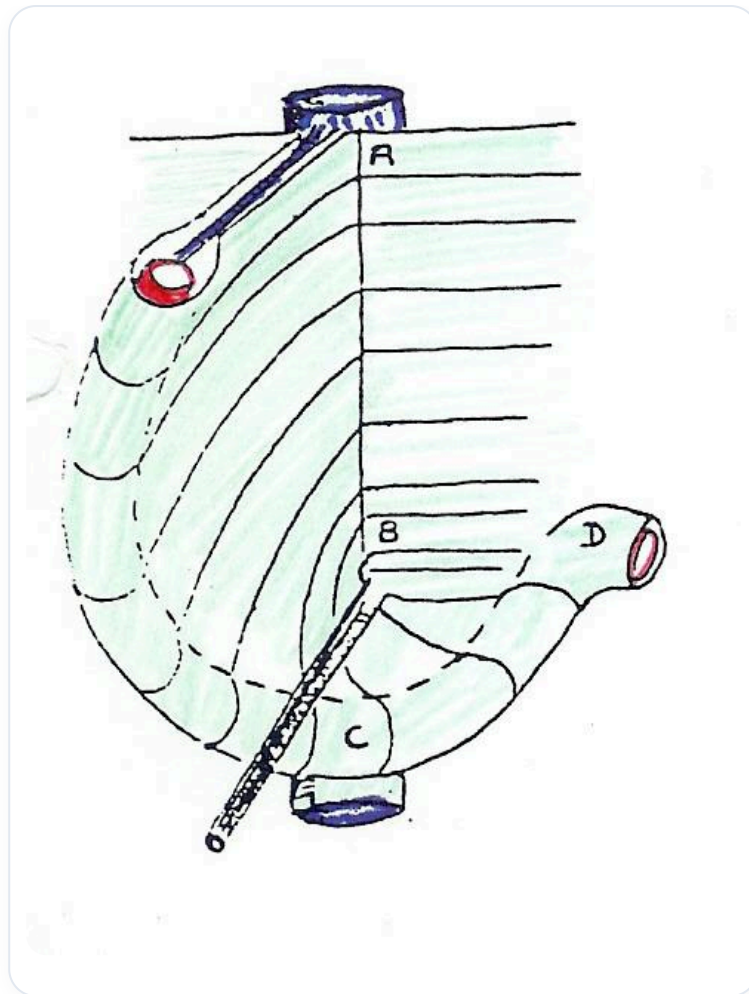
Appareil digestif embryonnaire



Intestin moyen, rotation

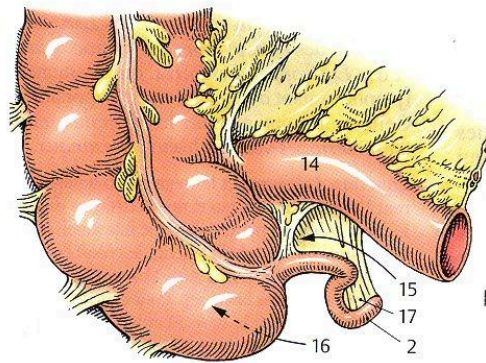


Intestin grêle vascularisé



Amniocentèse, Embryon, Utérus

Appendice vermiforme (A-C2). L'appendice prend naissance de l'*extrémité postéro-médiale du caecum*. Sa situation est très variable (**D**) : dans environ 65 p. 100 des cas, l'appendice est refoulé vers le haut derrière le caecum (*situation rétrocaecale haute*) ; dans 31 p. 100 des cas, elle dépasse la linea terminalis dans le petit bassin (*situation basse*) ; dans plus de 2 p. 100 des cas, il est horizontal derrière le caecum (*situation rétrocaecale transversale*) ; chez 1 p. 100 des hommes, il est refoulé vers le haut, en avant de l'iléon (*situation paracaecale, pré-iléale montante*) ; chez environ 0,5 p. 100, il est ascendant derrière l'iléon (*situation paracaecale, rétro-iléale montante*). Dans la **position la plus fréquente (rétrocaecale haute)**, la base de l'appendice vermiforme se projette sur la paroi abdominale antérieure, au **point de McBurney (E)**. Il se situe à la jonction entre le tiers externe et le tiers moyen d'une ligne tendue entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilic. L'appendice fait en moyenne 10 cm de long et 6 mm d'épaisseur. Les trois ténias du caecum (**C**) partent en étoile de la base de l'appendice, dans la paroi duquel ils forment une *couche musculieuse longitudinale fermée*.

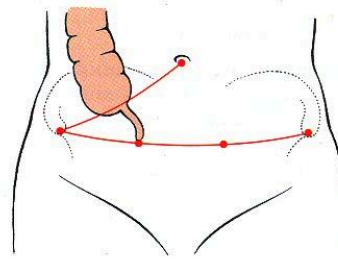


C Cæcum et appendice



65,28 %

D Variations de situation de l'appendice



E Projection de l'appendice sur la paroi abdominale antérieure



31,01 %



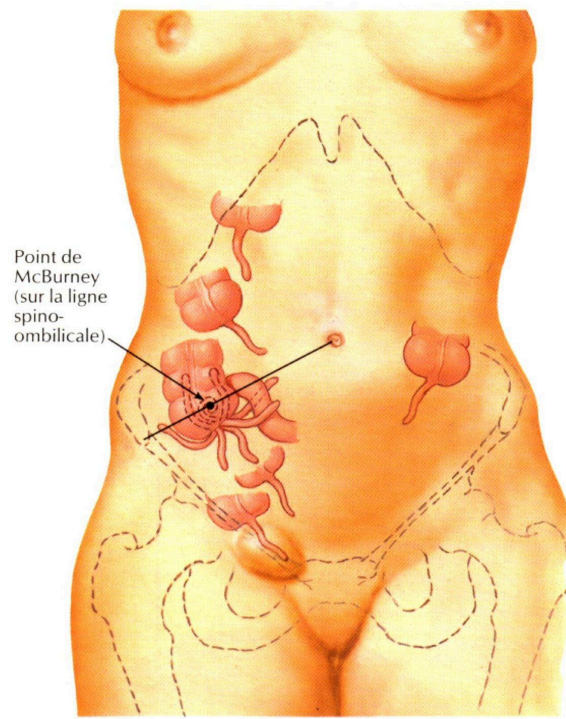
1,0 %



2,26 %



0,4 %

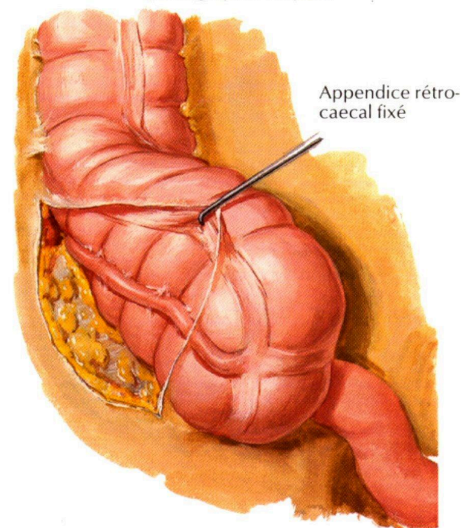


Point de
McBurney
(sur la ligne
spino-
ombilicale)

Variations de position de l'appendice

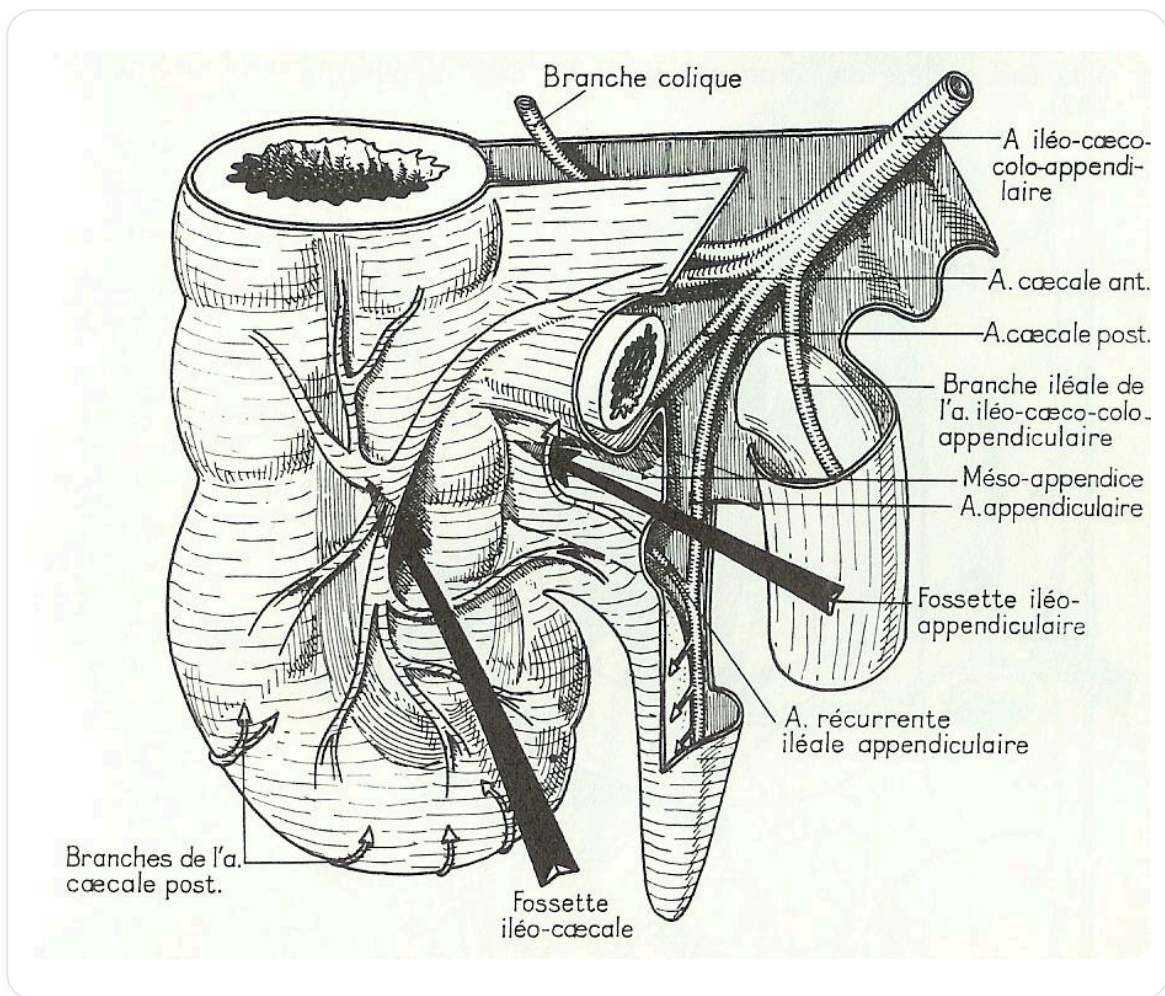


Appendice inhabituellement
long s'étendant dans le pelvis
(radiographie barytée)



Appendice rétro-
caecal fixé

Position de l'appendice



Vascularisation appendice caecum